

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **economía de la salud** estudia cómo se utilizan los recursos disponibles para mejorar la salud de la población, buscando el **mejor resultado posible con los recursos existentes**. En un sistema sanitario como el chileno —finito en recursos y creciente en demandas—, comprender los conceptos de **eficacia, efectividad y eficiencia** es esencial para la toma de decisiones clínicas y de gestión.

En el contexto del **EUNACOM**, estos términos son frecuentemente evaluados en relación con:

- Evaluación de programas y políticas públicas.
- Priorización de intervenciones en APS.
- Interpretación de resultados en estudios clínicos o de costo-beneficio.

Comprenderlos permite al médico general actuar no solo desde lo clínico, sino también desde la **racionalidad sanitaria**, optimizando la atención y garantizando **equidad y sustentabilidad** en salud.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

Los tres conceptos —**eficacia, efectividad y eficiencia**— describen distintos niveles de evaluación del desempeño de una intervención sanitaria o programa público.

Concepto	Definición	Contexto de aplicación
Eficacia	Capacidad de una intervención para producir el efecto esperado en condiciones ideales o controladas (ensayos clínicos, laboratorios).	Fase experimental o teórica.

Efectividad	Capacidad de producir resultados en condiciones reales de práctica clínica o comunitaria .	Contexto de aplicación práctica.
Eficiencia	Relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados (costo-beneficio).	Contexto económico o de gestión.

Ejemplo práctico:

- Una vacuna es **eficaz** si previene el 95 % de casos en ensayo clínico.
- Es **efectiva** si previene el 80 % en población general.
- Es **eficiente** si logra esa prevención con un costo razonable frente a otras estrategias.

3. Relaciones entre eficacia, efectividad y eficiencia

Estos tres conceptos están interrelacionados y representan un **continuum** entre investigación, aplicación y gestión:

Eficacia (ideal) → Efectividad (real) → Eficiencia (económica)

1. **Eficacia:** ¿Funciona en condiciones óptimas?
2. **Efectividad:** ¿Funciona en la práctica cotidiana?
3. **Eficiencia:** ¿Vale la pena comparado con su costo y beneficios?

En salud pública, los tres niveles deben coexistir para que una intervención sea sustentable. Por ejemplo, un fármaco puede ser muy eficaz, pero si su costo es desproporcionado respecto al beneficio, **no es eficiente ni éticamente justificable**.

4. Ejemplos aplicados en el contexto chileno

Intervención	Eficacia (estudios)	Efectividad (vida real)	Eficiencia (sistema público)
Vacuna COVID-19 (Pfizer/Sinovac)	Alta eficacia (>90 %)	Efectividad moderada (70–85 %) según edad y dosis	Muy eficiente por su bajo costo y alto impacto sanitario.
Tamizaje con PAP	Eficaz en detectar lesiones precancerosas	Efectiva en APS con cobertura >80 %	Eficiente por evitar cáncer cervicouterino avanzado.
Cirugía bariátrica	Alta eficacia en pérdida de peso y remisión de DM2	Efectiva en pacientes adherentes	Menos eficiente por su alto costo, indicada selectivamente (GES).
Control de hipertensión arterial en APS	Fármacos eficaces (IECA, ARA-II)	Efectividad variable por adherencia	Altamente eficiente: bajo costo, gran impacto en morbilidad.

5. Marco conceptual de evaluación sanitaria

La economía de la salud utiliza **indicadores de desempeño** para medir estas dimensiones:

5.1. Eficacia

- Se evalúa mediante **ensayos clínicos aleatorizados (ECA)**.
- Indicadores: reducción del riesgo relativo (RRR), odds ratio, número necesario a tratar (NNT).

5.2. Efectividad

- Se mide mediante **estudios observacionales y programas en población general**.
- Indicadores: tasas de cobertura, adherencia, reducción de incidencia/mortalidad.

5.3. Eficiencia

- Se evalúa mediante **análisis económicos**:
 - Costo–efectividad.
 - Costo–beneficio.
 - Costo–utilidad (en AVISA o DALYs).
-

6. Situación epidemiológica y sanitaria chilena (2024)

Chile enfrenta un sistema sanitario con **presión creciente sobre los recursos** debido a:

- Envejecimiento poblacional (13,5 % mayores de 65 años).
- Incremento de enfermedades crónicas no transmisibles.
- Demandas de cobertura universal (GES, Ley Ricarte Soto).
- Limitaciones presupuestarias en APS.

Por ello, la **eficiencia** se ha convertido en un principio rector de gestión sanitaria, impulsando políticas como:

- Priorización de intervenciones costo–efectivas.
 - Protocolos estandarizados (guías clínicas MINSAL).
 - Evaluaciones económicas previas a nuevas tecnologías (ETESA).
-

7. Normativa chilena y programas ministeriales vigentes

Marco normativo /
programa

Institución

Enfoque

Estrategia Nacional de Salud 2021–2030	MINSAL	Orienta políticas basadas en costo–efectividad y equidad.
Garantías Explícitas en Salud (GES/AUGE)	MINSAL	Prioriza problemas con mayor impacto sanitario y costo razonable.
Ley Ricarte Soto (20.850)	MINSAL–Fonasa	Cubre tratamientos de alto costo evaluados como eficientes.
ETESA (Evaluación de Tecnologías Sanitarias)	MINSAL	Analiza eficacia, efectividad y eficiencia de tecnologías antes de su incorporación.
Superintendencia de Salud	Regula aseguradores (FONASA, ISAPRE) y garantiza uso racional de recursos.	

8. Modelo de intervención y gestión en salud pública

8.1. Nivel de decisión

1. **Clínico:** aplicar intervenciones eficaces y efectivas.
2. **Programático:** priorizar estrategias eficientes y sustentables.
3. **Sistémico:** equilibrar gasto sanitario con resultados poblacionales.

8.2. Herramientas de gestión sanitaria

- **Protocolos de Guías Clínicas MINSAL.**
- **Matriz de priorización sanitaria (carga de enfermedad × costo × equidad).**

- **Análisis costo–efectividad incremental (ACEI).**
 - **Gestión por resultados e indicadores REM.**
-

9. Rol del médico general y competencias en APS

El **médico general** debe ser capaz de integrar los tres conceptos en su práctica diaria:

Rol	Ejemplo
Aplicar intervenciones eficaces	Usar tratamientos validados (ej. IECA en hipertensión).
Asegurar efectividad	Promover adherencia, seguimiento y control de factores de riesgo.
Favorecer eficiencia	Evitar exámenes innecesarios, derivar según protocolos, educar en autocuidado.
Participar en gestión local	Colaborar en priorización y evaluación de programas comunales.

10. Errores comunes en EUNACOM

Error frecuente	Corrección
Confundir eficacia con efectividad	Eficacia: condiciones ideales; efectividad: condiciones reales.

Pensar que **eficiencia** es solo ahorro

Es lograr **mejor salud al menor costo razonable**, no simplemente gastar menos.

Creer que un tratamiento eficaz siempre debe aplicarse

Debe ser también **efectivo y eficiente** en la población local.

Ignorar los **costos de oportunidad**

Recursos usados en una intervención no están disponibles para otra.

No relacionar con el GES o Ley Ricarte Soto

Ambos programas se basan en criterios de eficiencia y costo–efectividad.

11. Complicaciones y desafíos actuales

- **Sostenibilidad financiera:** aumento del gasto sanitario (8,4 % del PIB).
- **Inequidad territorial:** acceso desigual a intervenciones costo–efectivas.
- **Incorporación tecnológica acelerada:** alto costo de fármacos y biológicos.
- **Desafíos éticos:** decisiones de priorización y racionamiento de recursos.

Pronóstico:

La eficiencia en salud será un eje central del sistema chileno 2030, integrando criterios económicos, clínicos y éticos para garantizar cobertura universal sin comprometer la equidad.

12. Referencias ministeriales y técnicas

- MINSAL (2024). Estrategia Nacional de Salud 2021–2030.
- Superintendencia de Salud (2023). Informe de Financiamiento del Sistema Sanitario.

- OPS/OMS (2022). Economía de la Salud: principios y aplicaciones en políticas públicas.
 - Ley N.º 20.850. Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo (Ley Ricarte Soto).
 - ETESA. Guía metodológica para evaluación económica en salud (2023).
-

13. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. **Eficacia, efectividad y eficiencia** representan tres niveles de evaluación sanitaria: ideal, real y económico.
2. **Eficacia** se mide en condiciones controladas; **efectividad**, en práctica real; **eficiencia**, según relación costo–beneficio.
3. En Chile, los programas **GES y Ley Ricarte Soto** se basan en criterios de eficiencia y costo–efectividad.
4. La **economía de la salud** busca maximizar resultados sanitarios con recursos limitados.
5. El **médico de APS** debe aplicar intervenciones eficaces, asegurar efectividad y promover eficiencia.
6. La **evaluación económica (ETESA)** permite incorporar tecnologías de manera racional y justa.
7. La sostenibilidad futura del sistema depende de **eficiencia con equidad**, no de reducción indiscriminada de gastos.